

Clase 21 - Envejecimiento Normal y Patológico

- El pensamiento abstracto **declina** con el envejecimiento.
- El 'Ineco Frontal Screening' es un test de screening breve y sensible para la
- Evaluación específica de **Funciones Ejecutivas**.
- Criterios para el diagnóstico de Deterioro Cognitivo Leve:
 - Deterioro Cognitivo en uno o más dominios cognitivos
 - No cumple criterios para demencia
 - Preocupación referida a un cambio en el funcionamiento cognitivo
 - ~~Necesidad de asistencia constante en actividades funcionales~~
- Funciones Cognitivas que declinan con la edad:
 - Velocidad de procesamiento y Control Inhibitorio
 - Capacidad para adquirir nuevos aprendizajes
- El **DCL Amnésico** tiene mayor probabilidad de conversión a Demencia Tipo Alzheimer que los otros DCL.
- El factor de riesgo más importante para una demencia es la **edad**.
- Los pacientes con Deterioro Cognitivo Leve invariablemente progresan a algún tipo de Demencia.
- Características que debe tener un buen **Test de Screening Cognitivo**:
 - No afectarse demasiado por el sexo, la edad o los años de educación.
 - Estar estandarizado, ser cuantificable, ser replicable y tener alta sensibilidad y validez.
 - Fácil aplicación.
 - No requerir de gran cantidad de material.
- Ninguna versión del ACE evalúa la Cognición Social.
- Una **demencia** implica:
 - Deterioro cognitivo progresivo.
 - Déficit en varios dominios cognitivos.
 - Los déficit cognitivos y conductuales deben interferir con las actividades de la vida diaria (AVD) y la independencia funcional.

Clase 22 - Demencia Tipo Alzheimer

- La Enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de Demencia.
- Neuropatologías macroscópicas en la EA:
 - Atrofias Silvianas
 - Agrandamiento Ventricular
 - Atrofia del complejo hipocámpico
 - ~~Aumento del peso cerebral~~
- Las placas amiloides que se pueden observar a nivel microscópico en la EA **NO** se encuentran en el espacio intracelular.
- El principal componente de los ovillos neurofibrilares es la Proteína Tau.

- Factores de riesgo modificables para la Enfermedad de Alzheimer:
 - Dislipidemia
 - Estilo de vida poco saludable
 - Nivel de Educación
 - ~~La Edad~~
- Los pacientes menores de 65 años que presentan sintomatología compatible con EA **NO** tienen un mejor pronóstico por la mayor cantidad de tiempo disponible para el tratamiento antes de que el paciente fallezca.
- **EA Moderada**: Un paciente que presenta dificultades en la denominación que llegan a ser evidentes en la conversación y requiere de asistencia para las actividades de la vida diaria más complejas.
- **EA Severa**: Un paciente que presenta mutismo, falsos reconocimientos y necesidad de supervisión constante y dependencia para todas las actividades de la vida diaria.
- La EA es un ejemplo clásico del **Síndrome Amnésico Anterógrado**.
- Las **placas amiloide** se encuentran en el **Espacio Extracelular**.

Clase 24 - Demencia Frontotemporal VC

- El PET y el SPECT permiten observar cambios asociados a la DFT.
- Uno de los criterios para el DFTVC Probable es: "Atrofia desproporcionada en las regiones frontales mediales y/o orbitales/insular con o sin atrofia de las regiones temporales anteriores."
- La DFT es la segunda demencia neurodegenerativa más frecuente después de la Demencia Tipo Alzheimer.
- La presentación súbita y progresiva de los síntomas **NO** es característica de la DFT.
- **Test del Hotel y Reconocimiento de emociones** son pruebas que ayudarían a detectar dificultades específicamente ejecutivas y de la cognición social.
- Criterios necesarios para diagnóstico de DFT con patología definitiva: Evidencia histopatológica de DFT en biopsia o en estudio postmortem (tauopatía, TDP-43, DLDH).
- La desinhibición conductual temprana y los cambios en la alimentación y la hiperoralidad se consideran criterios diagnósticos para posible DFTVC.
- Un inicio insidioso y de progresión gradual de la sintomatología **NO** excluye el diagnóstico de DFT.
- Algunas diferencias entre "Fenocopias" y pacientes con DFTVC es que los síntomas de los primeros no suelen progresar y que pueden tener un mejor rendimiento en pruebas neuropsicológicas que los DFTVC.
- Características de la DFT Variante Conductual como entidad clínica-patológica:
 - Atrofia en lóbulos frontales y temporales anteriores
 - Deterioro de algunas funciones cognitivas
 - Deterioro de la personalidad
 - ~~Ataxia Cerebelosa~~

Clase 25 - Otras demencias

- La leucoaraiosis se puede entender como una pérdida difusa de la densidad en la sustancia blanca.
- La demencia por cuerpos de Lewy y la demencia asociada a Parkinson **NO** son lo mismo.
- La atrofia cortical posterior presenta los mismos hallazgos neuropatológicos que la EA pero distribuidos en áreas corticales diferentes.
- Es habitual observar apraxia de tipo ideomotor en la Degeneración Corticobasal.
- Las funciones para las cuales hay más evidencia de afectación en el deterioro cognitivo leve asociado a Parkinson son las Funciones Ejecutivas.
- En la enfermedad de Parkinson se observa pérdida de neuronas dopaminérgicas en la sustancia nigra.
- Los síntomas de la demencia vascular pocas veces varían en función de la localización de la lesión. (**Falso...** pero no se si **NUNCA** o si **SIEMPRE**)
- El síndrome de la mano ajena **NO** es un síntoma característico de la demencia asociada a Enfermedad de Parkinson.
- En la demencia por cuerpos de Lewy se observa inclusión de estos cuerpos a nivel subcortical pero no cortical. (**FALSO**)

Clase 27 - Perfil cognitivo de las principales enfermedades neurológicas

- Para el tratamiento de un tumor del SNC se suele usar radiación. Sin embargo, se ha observado que la dosis utilizada correlaciona con la exacerbación de déficits cognitivos.
- El tipo de Epilepsia más común es la Epilepsia del Lóbulo Occipital (ELO), en donde se observan dificultades a predominio visuoespacial. (**FALSO**)
- En la EM si bien se presentan ciertos síntomas cognitivos, la velocidad de procesamiento se encuentra conservada. (**FALSO**)
- Los meningiomas son un tipo de Tumor que se forman en el espacio entre el cráneo y el cerebro.
- En la Epilepsia, en las crisis parciales del lóbulo frontal se generan fallas de memoria.
- En las esclerosis múltiples (EM) la pérdida de mielina produce síntomas motores, sensitivos y cognitivos, pero nunca muerte axonal. (**FALSO**)
- En la EM tipo Brote-Remisión los síntomas continúan empeorando aun en los periodos intercríticos. (**FALSO**)
- Durante una crisis epiléptica generalizada hay pérdida o alteración de la conciencia.

Clase 26 - Perfil cognitivo de las principales enfermedades psiquiátricas

- Los pacientes con TB eutímicos presentan niveles preservados de inteligencia general (tanto premórbida como actual), aunque con fallas de tamaño moderado-grande en medidas de memoria verbal, atención sostenida y selectiva, y en los diferentes componentes de las funciones ejecutivas.
- Los pacientes con TB cursando tanto episodios maníacos como depresivos tienen alteraciones en la cognición social.
- En sus descripciones Kraepelin ya incluía alteraciones en el procesamiento atencional en la esquizofrenia.
- Los pacientes con TB que presentan alteraciones cognitivas durante los episodios atraviesan un proceso de restitución interepisódica *ad integrum*, es decir, que luego de controlados los episodios agudos logran una recuperación funcional plena, lo cual incluye a los síntomas cognitivos que pudieran haberse presentado durante los episodios. (**FALSO**)
- Según estudios en ADHD de Biederman, Mick y Faraone, mientras que los síntomas de hiperactividad e impulsividad pueden disminuir con la edad, los síntomas de atención se mantienen estables durante toda la vida.
- En la esquizofrenia, las dimensiones sintomatológicas más importantes son:
 - síntomas positivos.
 - síntomas negativos.
 - síntomas cognitivos.
- Los Trastornos Bipolares (TB) son un grupo de enfermedades psiquiátricas de base genética que determinan una inestabilidad patológica del ánimo y otros ritmos biológicos que puede distorsionar la conducta de los sujetos afectados.
- Hallazgos consistentes en la morfológica cerebral de pacientes con esquizofrenia:
 - Patología del sistema Límbico (reducción de componentes tisulares, alteraciones citoarquitectónicas)
 - Agrandamiento ventricular y dilatación regional cortical de los surcos.
 - Patología Talámica (reducción del volumen y número celular)
 - ~~Patología del tejido de regiones afectadas igual a deterioro cognitivo asociado a enfermedades neurodegenerativas~~
- Durante los episodios hipo/maníacos y depresivos las personas pueden sufrir alteraciones de la memoria verbal, atención, y funciones ejecutivas.
- En el ADHD las medidas neuropsicológicas (ejecutivas) tienen un bajo nivel predictivo negativo, es decir que el diagnóstico se puede descartar si se observan valores normales. (**FALSO**)